CUESTIONARIO 1 HEMATOLOGIA	2024
1. La segunda causa de muerte en la edad pediátrica es el cáncer. ¿Cuál es el tipo de cáncer más frecuente en esta edad (menores de 15 años)?	a.Leucemia linfática aguda b.Leucemia linfática crónica c.Leucemia mieloide aguda d.Leucemia mieloide crónica e.Linfoma
2. Identifique la asociación CORRECTA entre el cáncer y el factor pronóstico más importante:	a.El tamaño del tumor - Cáncer de tiroides b.La presencia de adenopatías - Cáncer gástrico c.El tamaño del tumor - Cáncer de mama d.El grado histológico de diferenciación - Sarcoma e.La presencia de metástasis a distancia - Linfoma de Hodgkin
3. Un paciente de 55 años consulta por epistaxis. Se realiza un hemograma con hematocrito: 50%, plaquetas: 800.000 por mm3 y blancos: 9.400 por mm3, con fórmula diferencial normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?	a.Trombocitosis reactiva b.Mielodisplasia c.Púrpura trombocitopénico trombótico d.Trombocitosis esencial e.Macroglobulinemia de Waldestrom
4. Un paciente de 15 años presenta anemia crónica. En sus exámenes destaca un hemograma con anemia microcítica, con VCM de 66, con hematocrito de 33% y 5 millones de GR por mm3. Además, tiene ferritina ligeramente elevada. El diagnóstico de sospecha es:	a.Microesferocitosis familiar b.Anemia ferropénica c.Anemia drepanocítica (por células falciformes) d.Anemia por enfermedades crónicas e.Talasemia
5. Un paciente de 50 años, sin antecedentes de importancia, presenta una TVP de extremidad inferior izquierda. Además de los signos de TVP, al examen físico se aprecia piel violácea. En sus exámenes destaca hemograma con hematocrito: 63%, Hb: 21 g/dl, plaquetas: 460.000 x mm3 y blancos: 9.000 x mm3, con fórmula diferencial normal. No fuma, no tiene enfermedades pulmonares y no ha vivido en altura. ¿Qué alteración es más probable de encontrar en este paciente?	a.Cromosoma Filadelfia b.Esplenomegalia c.Poliadenopatías d.Positividad de la prueba de Coombs directo e.Positividad de la prueba de Coombs indirecto
6. Una mujer de 80 años se realiza un hemograma, que muestra leucocitosis de 40.000 x mm3, con 90% de linfocitos y anemia moderada. Al examen físico no se aprecian alteraciones y en un examen anterior, realizado hace un año, se constata leucocitosis de 30.000 x mm3, también de predominio linfocitario. El diagnóstico más probable es:	a.Leucocitosis reactiva a infección viral crónica b.Leucemia linfática crónica c.Mielofibrosis d.Reacción leucemoide e.Linfoma
7. Un niño de 3 meses, asintomático, alimentado con leche materna, presenta hemograma con hemoglobina de 9,2 g/dl, sin alteración de las otras series de células sanguíneas. La conducta más adecuada es:	a.Solicitar biopsia de médula ósea b.Solicitar perfil de hierro, niveles de vitamina B12 y folatos c.Iniciar tratamiento con hierro oral d.Observar evolución e.Solicitar pruebas de screening para talasemias
8. El síndrome antifosfolípido se caracteriza por:	a.Alargamiento del tiempo de sangría b.Alargamiento del tiempo de protrombina c.Alargamiento del tiempo de tromboplastina parcial activada d.Disminución del recuento de plaquetas e.Alteración de las pruebas de agregación plaquetaria
9. Paciente de 60 años, operado por cáncer gástrico, hace 3 años, consulta por astenia, adinamia y debilidad. Al examen pálido, con escasas petequias en extremidades superiores. El hemograma muestra Hematocrito: 23%, VCM: 120, blancos: 3.000, con fórmula diferencial normal, plaquetas: 85.000. Al frotis se aprecia macrocitosis, macroplaquetas y aumento de la segmentación del núcleo de los neutrófilos. El examen más adecuado para continuar el estudio etiológico es:	a.Biopsia de médula ósea b.Radiografía de calota c.Electroforesis de proteínas en sangre y orina d.Niveles de vitamina B12 e.Citometría de flujo en sangre periférica
10. El tratamiento del púrpura trombocitopénico agudo, en un niño, con petequias en las EEII y 80.000 plaquetas por mm3, es:	a.Corticoides orales b.Ácido acetil salicílico c.Cumarínicos orales d.Esplenectomía e.Reposo y observación
11. Un paciente de 63 años, diagnosticado de artrosis, usuaria de paracetamol e ibuprofeno, consulta por aparición de múltiples petequias en las extremidades inferiores y en el tronco, asociado a	a.Disfunción plaquetaria por ibuprofeno b.Púrpura trombocitopénico inmune c.Púrpura trombocitopénico trombótico

Lia...

epistaxis y algunas equimosis en EEII. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 45%, hemoglobina: 15 g/dl, plaquetas: 30.000 por mm3, blancos: 7.200 por mm3, con fórmula diferencial normal. El diagnóstico más probable es:	d.Hemofilia e.Enfermedad de Von Willebrand
12. Un paciente de 70 años presenta astenia de algunas semanas de evolución, asociada a fiebre, por lo que se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 27%, plaquetas: 70.000 por mm3 y glóbulos blancos: 45.000 por mm3, con 16% de segmentados, 0% de baciliformes, 0% de mielocitos, 40% de promielocitos, 37% de blastos, 0% eosinófilos, 0% de basófilos y 7% linfocitos. No ha presentado otros síntomas y su examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:	a.Infección viral b.Infección bacteriana c.Leucemia aguda d.Leucemia mieloide crónica e.Linfoma
13. Un paciente de 45 años presenta un cuadro de fiebre y malestar general, de 5 días de evolución. Su hemograma muestra Hemoglobina: 14 g/dl, plaquetas: 400.000 por mm3, blancos: 16.000 por mm3, con 10% de linfocitos, 5% de monocitos y 70% de neutrófilos segmentados y 15% de baciliformes. El diagnóstico más probable es:	a.Infección viral b.Infección bacteriana c.Leucemia aguda d.Leucemia mieloide crónica e.Linfoma
14. Una paciente de 50 años presenta un cuadro de astenia y adinamia de dos meses de evolución, asociada a palidez de piel y mucosas. Se solicita un hemograma, que demuestra anemia normocítica, con hematocrito de 28%, hemoglobina: 9,1 g/dl y VCM de 80 fl. Se solicita perfil de hierro, que muestra ferritina disminuida y transferrina elevada, con ferremia disminuida. La conducta más adecuada es:	a.Solicitar biopsia de médula ósea b.Iniciar estudio, en busca de una enfermedad crónica, que explique la anemia c.Iniciar sulfato ferroso oral hasta normalizar el perfil de fierro d.Iniciar tratamiento con sulfato ferroso, vitamina B12 y folatos e.Hospitalizar y tratar con transfusiones de glóbulos rojos
15. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es MENOS probable es un paciente con anemia hemolítica autoinmune?	a.Presencia de esquistocitos b.Aumento de la bilirrubina indirecta c.Aumento del lactato deshidrogenasa plasmática d.Prueba de Coombs directa positiva e.Disminución de los eritrobastos y otras formas inmaduras de glóbulos rojos, en la médula ósea
16. Un paciente de 65 años, consulta por anemia. Al examen físico se constata palidez, y algunas petequias en las extremidades inferiores. Su examen físico no aporta mayor información. Se solicita un hemograma, que muestra Hematocrito: 25%, plaquetas: 20.000 por mm3 y blancos: 2.700 por mm, VCM: 108, VHS: 24 mm/h. Además, se solicita un perfil bioquímico, que destaca LDH elevada. Su recuento de reticulocitos es de 0,5% y sus niveles plasmáticos de ácido fólico y vitamina B12 están normales. El diagnóstico más probable es:	a.Mieloma múltiple b.Mielofibrosis c.Leucemia d.Mielodisplasia e.Anemia perniciosa
17. Un niño de 6 años presenta un cuadro de fiebre, baja de peso y sudoración nocturna, asociada a malestar general. Al examen físico, se palpa varias adenopatías inguinales y axilares indoloras. Su hemograma demuestra anemia normocítica leve, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:	a.Realizar biopsia esplénica b.Iniciar corticoides orales c.Solicitar biopsia de médula ósea d.Solicitar biopsia ganglionar e.Solicitar hibridación in situ, en busca del Cromosoma Filadelfia.
18. Un paciente de 40 años presenta astenia, por lo que se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 20%, hemoglobina: 6,5%, plaquetas: 32.000 por mm3, blancos, 3.200, con 55% de linfocitos, 15% de monocitos y 30% de neutrófilos. La conducta más adecuada es:	a.Iniciar tratamiento con sulfato ferroso, folatos y vitamina B12 y controlar ambulatoriamente b.Iniciar tratamiento con corticoides orales c.Solicitar electroforesis de proteínas d.Solicitar biopsia de médula ósea e.Solicitar niveles plasmáticos de vitamina B12
19. Un paciente presenta resistencia del factor V a la acción de la proteína C. Tendrá alto riesgo de:	a.Hemorragias b.Infecciones c.Leucemia d.Linfoma e.Trombosis
20. Un niño de 3 años presenta una hemartrosis de rodilla, en relación a un golpe de moderada intensidad. Además, ha presentado varios hematomas profundos (musculares) y al examen físico se aprecian equimosis en varias zonas de la piel. ¿Qué diagnóstico es el más probable?	a.Púrpura trombocitopénico inmune b.Enfermedad de Von Willebrand c.Hemofilia d.Leucemia aguda e.Déficit de antitrombina III

Lia...

CUESTIONARIO 2 HEMATOLOGIA	2024
1. Un paciente de 63 años, diagnosticado de un púrpura trombocitopénico inmune crónico, en tratamiento con prednisona 40 mg al día, presenta hemorragia digestiva alta, asociada a epistaxis importante. Se inicia reposición de volumen y taponamiento nasal anterior y solicita hemograma, que muestra 3.000 plaquetas por mm3. Además del manejo de su hemorragia digestiva, la conducta más adecuada es:	a.Realizar transfusión de plaquetas b.Administrar pulsos de metilprednisolona endovenosa c.Realizar esplenectomía d.Transfundir plasma fresco congelado e.Administrar inmunoglobulina G endovenosa más pulsos de metilprednisolona
2. Un paciente de 70 años presenta astenia de algunas semanas de evolución, por lo que se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 27%, plaquetas: 70.000 por mm3 y glóbulos blancos: 25.000 por mm3, con 95% de linfocitos. No ha presentado otros síntomas y su examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:	a.Infección viral b.Infección bacteriana c.Leucemia aguda d.Leucemia linfática crónica e.Linfoma
3. Un paciente de 45 años presenta un cuadro de fiebre y malestar general, de 5 días de evolución. Su hemograma muestra Hemoglobina: 14 g/dl, plaquetas: 400.000 por mm3, blancos: 18.000 por mm3, con 65% de neutrófilos segmentados, 20% de baciliformes, 15% de linfocitos. El diagnóstico más probable es:	a.Infección viral b.Infección bacteriana c.Leucemia aguda d.Leucemia mieloide crónica e.Linfoma
4. Una paciente de 40 años presenta un cuadro de astenia y adinamia de dos meses de evolución, asociada a palidez de piel y mucosas. Se solicita un hemograma, que demuestra anemia microcítica, con hematocrito de 25%, hemoglobina: 7,8% y VCM de 68 fl. Se solicita perfil de hierro, que confirma ferropenia. La conducta más adecuada es:	a.Solicitar biopsia de médula ósea b.Iniciar sulfato ferroso oral hasta normalizar el hematocrito c.Iniciar sulfato ferroso oral hasta normalizar el perfil de fierro d.Iniciar tratamiento con sulfato ferroso, vitamina B12 y folatos, hasta normalizar el VCM e.Hospitalizar y tratar con transfusiones de glóbulos rojos
5. Una paciente presenta un cuadro de anemia, con marcada elevación de los reticulocitos y presencia de esquistocitos. ¿Qué examen es más adecuado para el estudio de esta paciente?	a.Prueba de Coombs directo b.Niveles de vitamina B12 c.Biopsia de médula ósea d.Ferritina y transferrina plasmáticas e.Tiempo de sangría
6. Un paciente de 65 años, es diagnosticado de cáncer gástrico, por lo que se le realiza una gastrectomía total y posterior quimioterapia. Evoluciona con baja de peso y anemia. Su hemograma muestra un hematocrito de 24%, hemoglobina de 8,7 g/dl, plaquetas: 80.000 y blancos: 3.200 por mm3. El volumen corpuscular medio es 118 fl y la concentración corpuscular media de hemoglobina es 36 pg. El diagnóstico más probable es:	a.Aplasia medular b.Mieloptisis c.Anemia ferropénica d.Anemia por enfermedades crónica e.Anemia por déficit de vitamina B12
7. Un paciente de 70 años se realiza un hemograma, que muestra anemia con hematocrito de 30%, Hemoglobina de 10 g/dl, VCM: 101 fl, VHS: 30 mm/h, blancos: 3.000 por mm3 y plaquetas: 90.000 por mm3. Se iniciar tratamiento con vitaminas del complejo B y se controla un mes después, persistiendo con un hemograma muy similar. La conducta más adecuada es:	a.Mantener el tratamiento y observar evolución b.Iniciar corticoides orales c.Solicitar perfil de hierro d.Solicitar estudio de médula ósea e.Solicitar niveles de ácido metilmalónico y homocisteína
8. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más frecuente en los pacientes diagnosticados de linfoma?	a.Adenopatías b.Anemia c.Elevación de las proteínas plasmáticas d.Dolores óseos e.Esplenomegalia
9. Un paciente presenta un TEP, que es manejado con heparina endovenosa y posteriormente tratamiento anticoagulante oral, con acenocumarol. ¿Qué examen es el más adecuado para ajustar la dosis del acenocumarol?	a.Tiempo de sangría b.Tiempo de tromboplastina parcial activada c.INR (International Normalized Ratio) d.Recuento de plaquetas e.No necesita ningún examen, ya que la dosis se determina según el peso y la evolución clínica
10. Un niño presenta un púrpura petequial, asociado a aparición de equimosis en las extremidades inferiores. La conducta más adecuada es:	a.Iniciar corticoides orales b.Solicitar un hemograma y controlar ambulatoriamente con el resultadoc.

Lia...

	Solicitar una biopsia de médula ósea d.Iniciar aspirina oral e.Hospitalizar para estudio
11. La trombofilia congénita más frecuente es:	a.Factor V de Leiden b.Déficit de antitrobina III c.Déficit de proteína C d.Déficit de proteína S e.Hiperhomocisteinemia
12. En una poliglobulia, todos los datos siguientes concuerdan con una policitemia vera, EXCEPTO uno. Señálelo:	a.Aumento de la masa de hematíes. b.Esplenomegalia. c.Leucocitosis y trombocitosis. d.Eritropoyetina sérica alta. e.Saturación arterial de oxígeno normal.
13. Un adolescente de 15 años consulta por fiebre y odinofagia, de 8 días de evolución. Al examen físico se aprecia con ictericia leve, T°: 38,5°C y se palpan múltiples adenopatías cervicales sensibles. La faringe está eritematosa, con aumento de volumen amigdalino y escaso exudado blanquecino. Además, es posible palpar el bazo. El diagnóstico más probable es:	a.Leucemia aguda b.Linfoma c.Mononucleosis infecciosa d.Anemia hemolítica autoinmune e.Leucemia linfática crónica
14. Un paciente de 67 años se realiza un perfil bioquímico que muestra elevación de las proteínas plasmáticas, con albúmina de 3,4 g/dl. Los exámenes generales son normales, al igual que el examen físico. Se solicita una electroforesis de proteínas en plasma, que constata un peak monoclonal de inmunoglobulina G, por lo que se realiza una realiza una biopsia de médula ósea que demuestra elevación del número de plasmocitos, compatible con un MGUS. La conducta más adecuada es:	a.Observar evolución b.Indicar quimioterapia c.Iniciar ácido acetil salicílico d.Iniciar hidroxiurea e.Realizar trasplante de médula ósea
15. Paciente de 65 años presenta en su analítica creatinina de 2,1, anemia con Hb:9,7 e hipercalcemia de 11,1. El diagnóstico de sospecha es:	a.Insuficiencia renal crónica, con hiperparatiroidismo asociado b.Anemia de enfermedades crónicas c.Mieloma múltiple d.Déficit de proteína C e.Cáncer de próstata
16. Paciente de 45 años, consulta porque le indicaron que padecía de anemia. El hemograma constata recuento de blancos y plaquetas normales, Hcto: 33%, Hb: 11 mg/dl, VCM: 70. En el frotis se aprecia anisocitosis con aumento del índice de dispersión eritrocítica. El diagnóstico más probable es:	a.Talasemia b.Anemia ferropénica c.Anemia de enfermedades crónicas d.Anemia hemolítica crónica e.Hemocromatosis
17. Mujer de 24 años consulta por fiebre, baja de peso y sudoración nocturna. Al examen presenta poliadenopatías cervicales. El hemograma es normal. La radiografía de tórax muestra mediastino ensanchado. El diagnóstico más probable es:	a.Infección por Bartonella henselae b.Tuberculosis c.Linfoma d.Leucemia e.Timoma
18. Un paciente de 55 años presenta una celulitis en el pie izquierdo, la que se trata con cloxacilina y ketoprofeno. Se solicita un hemograma que demuestra leucocitosis de 15.000 con desviación izquierda, sin embargo, llama la atención el número de plaquetas, que asciende a 550.000 por mm3. ¿Cuál es la causa más probable de su trombocitosis?:	a.Reactiva, secundaria a la inflamación b.Autoinmune c.Secundaria a la cloxacilina d.Trombocitosis esencial e.Secundaria al ketoprofeno
19. El factor pronóstico más importante del cáncer de laringe es:	a.Tipo histológico b.Invasión de los ganglios linfáticos cervicales c.Grado de diferenciación histológica d.Presencia de metástasis a distancia e.Tamaño del tumor
20. Una paciente de 40 años se realiza una especuloscopía que resulta normal, tomándose un PAP que es informado como muestra satisfactoria, con presencia de células displásicas de alto grado. La conducta más adecuada es:	a.Derivar a patología cervical, para realización de colposcopía y biopsia de la lesión b.Repetir el PAP en un año c.Realizar cono cervical d.Repetir el PAP inmediatamente e.Repetir el PAP en 3 meses

Lia...

CUESTIONARIO 3 HEMATOLOGIA	2024
1. Un niño de 8 años presenta fiebre y malestar general de dos semanas de evolución. Al examen se aprecia pálido, con algunas equimosis y petequias en las extremidades. Además, se palpa esplenomegalia moderada. El diagnóstico más probable es:	a.Púrpura trombocitopénico trombótico b.Púrpura trombocitopénico inmune c.Leucemia mieloide crónica d.Linfoma no Hodgkin e.Leucemia linfática aguda
2. Un paciente de 80 años consulta por dolores óseos y astenia. Al examen físico está pálido, sin otras alteraciones. En sus exámenes generales destaca un hemograma con anemia y plaquetopenia, una creatinina de 2,4 mg/dl y un calcio de 13,6 mg/dl. La conducta más adecuada es:	a.Solicitar radiografía de cráneo, electroforesis de proteínas y biopsia de médula ósea b.Solicitar radiografía de tórax y biopsia de ganglio linfático c.Iniciar prednisona oral y controlar ambulatoriamente d.Realizar esplenectomía y solicitar hemograma de control e.Observar evolución
3. Una paciente de 25 años, sin antecedentes de importancia, es diagnosticada de anemia ferropénica, con hematocrito de 30%, hemoglobina de 8,6 mg/dl y perfil de fierro compatible. Ella refiere reglas regulares y abundantes y su examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:	a.Indicar aumento de la ingesta de carnes rojas (Ej: vacuno e hígado) y vegetales color verde oscuro (Ej: acelgas y espinacas) b.Indicar sulfato ferroso vía oral y vitamina B12 vía intramuscular c.Iniciar sulfato ferroso por vía oral e indicar uso de anticonceptivos orales d.Solicitar colonoscopía e.Indicar biopsia de médula ósea
4. Un paciente presenta anemia, con hematocrito: 25%, VCM: 110 fl, plaquetas: 250.000 por mm3, blancos: 6.000 por mm3, reticulocitos: 10%. Además, se constata elevación de la bilirrubina plasmática de predominio indirecto y de la LDH (lactato deshidrogenasa). El diagnóstico más probable es:	a.Anemia hemolítica b.Anemia por enfermedades crónicas c.Mielodisplasia d.Anemia perniciosa e.Anemia por déficit de folatos
5. Una paciente de 50 años presenta epistaxis en varias oportunidades en el último mes, asociado a sangramiento de las encías al cepillarse los dientes. Al examen físico se aprecian múltiples petequias generalizadas, con algunas equimosis. No ha presentado otros síntomas. La conducta más adecuada es:	a.Solicitar tiempos de coagulación b.Solicitar hemograma c.Solicitar biopsia de piel d.Iniciar aspirina e.Iniciar corticoides
6. Un paciente de 70 años consulta por astenia. Al examen físico se encuentra pálido, sin otras alteraciones, por lo que se solicita un hemograma que muestra Hematocrito: 27%, hemoglobina: 9 g/dl, VCM: 103 fl, plaquetas: 60.000 x mm3, blancos: 2.500 x mm3, con fórmula diferencial normal. Se inicia tratamiento con vitamina B12 y folatos por vía parenteral y se controla 3 meses después, sin presentar mejoría. El diagnóstico más probable es:	a.Mielofibrosis b.Mieloma múltiple c.Aplasia medular d.Anemia perniciosa e.Mielodisplasia
7. Un paciente de 60 años presenta anemia, con Hcto: 31% y VCM: 90 fl. Se solicita un perfil de hierro, que muestra ferremia baja, ferritina elevada y transferrina baja. El diagnóstico más probable es:	a.Anemia ferropénica b.Talasemia c.Anemia sideroblástica d.Anemia de enfermedades crónicas e.Asociación de anemia ferropénica y anemia por déficit de vitamina B12
8. ¿Cuál de las siguientes opciones orienta al diagnóstico de policitemia vera, en un paciente con poliglobulia?	a.Disminución de los reticulocitos b.Disminución de la presión parcial de oxígeno c.Elevación de la eritropoyetina d.Trombocitopenia e.Esplenomegalia
9. ¿Cuál de los siguientes hemogramas le parece más sugerente de una leucemia linfoide crónica?	a.Hematocrito: 45%, hemoglobina: 15 g/dl, plaquetas: 250.000 x mm3, blancos: 7.500 x mm3, linfocitos: 50%, Monocitos: 4%, segmentados: 40%, baciliformes: 3%, mielocitos: 0%, promielocitos: 0%, blastos: 0%, eosinófilos: 2%, basófilos: 1% b.Hematocrito: 25%, hemoglobina: 8 g/dl, plaquetas: 50.000 x mm3, blancos: 27.500 x mm3, linfocitos: 88%, Monocitos: 0%, segmentados: 12%, baciliformes: 0%, mielocitos: 0%, promielocitos: 0%, blastos: 0%, eosinófilos: 0%, basófilos: 0% c.Hematocrito: 45%, hemoglobina: 15 g/dl, plaquetas: 250.000 x mm3, blancos: 17.500 x mm3, linfocitos: 13%, Monocitos:

Lia...

	5%, segmentados: 65%, baciliformes: 15%, mielocitos: 0%, promielocitos: 0%, blastos: 0%, eosinófilos: 1%, basófilos: 1% d.Hematocrito: 45%, hemoglobina: 15 g/dl, plaquetas: 500.000 x mm3, blancos: 32.500 x mm3, linfocitos: 10%, Monocitos: 5%, segmentados: 31%, baciliformes: 21%, mielocitos: 10%, promielocitos: 5%, blastos: 2%, eosinófilos: 6%, basófilos: 4% e.Hematocrito: 45%, hemoglobina: 15 g/dl, plaquetas: 350.000 x mm3, blancos: 18.500 x mm3, linfocitos: 80%, Monocitos: 7%, segmentados: 12%, baciliformes: 1%, mielocitos: 0%, promielocitos: 0%, blastos: 0%, eosinófilos: 0%, basófilos: 0%
10. ¿Cuál de las siguientes opciones es más sugerente de hemofilia?	a.Hipermenorrea b.Petequias y equimosis c.Presencia de hemartrosis y hematomas profundos d.Alargamiento del tiempo de protrombina e.Alargamiento del tiempo de sangría